

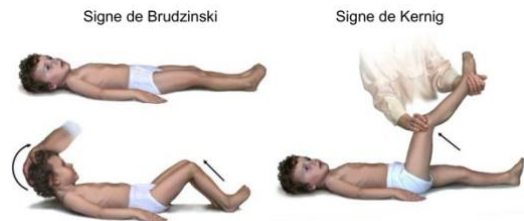
## Céphalée

1. Rechercher des **drapeaux rouges**
  - a. **Type de douleur**
    - i. **Pas comme d'habitude, différente** (surtout si > 50 ans)
    - ii. **La pire**
    - iii. **En coup de tonnerre +/- céphalée sentinelle (HSA)**
    - iv. **Positionnelle, à l'effort** (*hémorragie, rupture anévrisme*)
    - v. **Profil évolutif défavorable**
  - b. **Contexte**
    - i. **Grossesse / post-partum** (*thrombophlébite*)
    - ii. HIV, immunosuppression
    - iii. Anticoagulant, consommation d'alcool
    - iv. **Traumatisme crânien**
    - v. Manipulation ou trauma nuque
    - vi. **Baisse de l'état général, perte de poids** (cancer, métastase)
  - c. Clinique
    - i. **Symptômes neuro récents** inhabituels – examen neuro anormal
      1. Mydriase
      2. myosis + ptosis (Horner) (*dissection carotidienne*)
    - ii. Horton
      1. Douleurs temporales en lien avec l'a. temporale
      2. Douleurs au passage du peigne ou de la mastication
      3. Douleurs ceintures
      4. Altération de l'état général
    - iii. **Rash – éruption cutanée**
    - iv. **Méningisme – raideur de nuque**
    - v. **Fièvre** sans autre foyer clinique
    - vi. HTA sévère > 180/120 – hypertension maligne
2. Caractérisation des céphalées
  - a. Durée des céphalées - évolution
  - b. Localisation : douleur unilatérale vs bilatérale
  - c. Caractère : pulsatile vs pression – étai
  - d. Intensité
  - e. Aggravation ou pas par les activités physiques de routine
  - f. Nausée, vomissement
  - g. Photophonophobie
  - h. Aura (signes positifs)
3. Symptômes associés
  - a. Injection conjonctivale, larmolement
  - b. Sensation de plénitude de l'oreille
  - c. Congestion nasale
  - d. Myosis, ptosis
  - e. Sudation, rougeur du front et de la face
  - f. Œdème de la paupière
  - g. Agitation
4. ATCD personnel
  - a. Maladie – hospitalisation – opération

- b. Médicaments
- c. Allergies
- 5. ATCD familiaux
- 6. Habitude
  - a. Diète - Tabac – alcool – drogue (**cocaïne**) – AP

Examen clinique :

- Examen neurologique
  - Orientation – niveau attentionnel
  - Station debout et marche
  - Épreuves cérébelleuses
  - Nerfs crâniens
  - **Signe méningé (Brudzinski, Kernig)**
  - Signes de latéralisation : voies longues (grossièrement)
  - **Cincinnati : bras tendu + n. VII + répéter phrase après moi**
  - FO
- **Rash → inspection de tout le corps**
- **Auscultation carotidienne** et cardio
- Examen dirigé selon l'anamnèse :
  - **Palpation des artères temporales**
  - ORL – percussion des sinus
  - Stomatologique – examen dentition
  - Palpation ATM
  - Rachis cervical



Laboratoire

- VS si céphalée inaugurale à > 50 ans – suspicion Horton
- FS, hémocultures si suspicion méningite
- Crase si suspicion hémorragie ou pathologie chirurgicale
- PL si suspicion HSA, méningite ou méningite carcinomateuse

Imagerie

- CT si signe d'alarme sauf si suspicion méningite ou artérite temporale
- IRM si suspicion pathologie fosse post., charnière occipitale, pathologie vasculaire

DD :

- *Céphalée primaire :*
  - *Migraine*
  - *Céphalée de tension*
  - *Névralgie du trijumeau*
  - *Névralgie occipitale*
  - *Cluster headache*
- *Céphalée secondaire*
  - *AVC*
  - *Méningite*
  - *Hémorragie sous arachnoïdienne*
  - *Hématome sous-dural*
  - *Dissection (carotidienne ou vertébrale)*
  - *Thrombophlébite – thrombose veineuse*
  - *Cancer – métastase*
  - *Artérite temporale – Horton*

### Migraine épisodique (< 15j/mois)

Symptômes :

- Céphalées durent **4 à 72 heures** (sans ttt)
- **Au moins 2** des caractéristiques suivantes
  - o Localisation **unilatérale**
  - o Caractère **pulsatile**
  - o Intensité **modérée à sévère**
  - o **Aggravation par les activités** physique de routine
- **Au moins 1** des caractères suivants
  - o **Nausée / vomissement**
  - o **Photophonophobie** (aggravée par la lumière et par le bruit)

Traitement :

- Crise
  - o AINS – paracétamol
  - o Triptan
- De fond
  - o Beta-bloquant
  - o Anti-calcique
  - o Anti-épileptique
  - o Antidépresseurs tricycliques
  - o Anticorps monoclonaux

### Céphalées de tension

Symptômes :

- Céphalée dure de **30 minutes à 7 jours**
- **Au moins 2** des caractéristiques suivantes
  - o Localisation **bilatérale**
  - o A type de **pression ou d'étouffement**
  - o Intensité **légère à modérée**
  - o **Non aggravée par les activités** physiques de routine
- Aucun des caractères suivants
  - o **Nausée/vomissement**
  - o **Photophonophobie**

Traitement :

- Crise : AINS
- Traitement de fond
  - o Médicamenteux : antidépresseurs tricycliques
  - o Non médicamenteux : relaxation, acupuncture, gymnastique posturale

### Algie vasculaire de la face = céphalées en grappe = cluster headache

C'est une hémicrânie trigémino-dysautonomique. Les patients rapportent des douleurs très sévères unilatérales orbitaire, supra-orbitaire, temporelle pendant **15 à 180 minutes**.

Pour poser le diagnostic il faut **au moins 1** des signes suivants, **du côté** de la douleur :

- Œil rouge
- Injection conjonctivale, larmolement
- Sensation de plénitude de l'oreille
- Congestion nasale ou rhinorrhée
- Myosis ou ptosis
- Sudation du front et de la face
- Rougeur du front et de la face
- Œdème de la paupière
- **Agitation**

Traitement :

- Crise
  - o O<sub>2</sub> masque avec 10-12 l pendant 15 minutes
  - o Triptan
- De fond
  - o Anticalciques

### Céphalées et névralgies occipitales

- Névralgies du nerf d'Arnold
  - o Territoires des nerfs grands et petits occipitaux
  - o En coup de poignard
  - o Provoquée par des mouvements de la tête
  - o Sensibles à la palpation
  - o Douleur soulagée temporairement par un bloc local (permet diag)
- Névralgies trigéminales
  - o Femme après 50 ans
  - o Douleurs brèves (sec.) mais répétées (jusqu'à 100x/j)
  - o Décharge électrique ou brûlure dans territoire du trijumeau (une ou plusieurs branches)
  - o Zone gachette : toucher, parler, brossage des dents, manger
  - o Porte la main au visage qui se crispe (tic douloureux)
  - o Pas d'hypoesthésie

DD :



| <u>Syndrome méningés</u>                                                      | <u>Hypertension intracrânienne</u>                                                                                                                                                                   | <u>Hypotension intracrânienne</u>                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position allongée en chien de fusil                                           | Prédominant en décubitus, le <b>matin</b> au réveil                                                                                                                                                  | <b>Prédominant en orthostatisme</b>                                                                                              |
| Nausée, vomissement                                                           | <b>Nausée, vomissement en jet</b> , le matin au réveil                                                                                                                                               | Nausée après orthostatisme prolongé                                                                                              |
| Raideur douloureuse de la nuque                                               | <b>Flou visuel</b> et œdème papillaire au fond d'œil (+/- atteinte de n. VI → diplopie)                                                                                                              | <b>Acouphènes</b> , troubles « fonctionnels » divers                                                                             |
| <b>Hémorragie méningée</b> (apyrétique, brutal), <b>méningite</b> (pyrétique) | <b>Thrombophlébite cérébrale</b> (favorisé par facteurs pro-thrombotique + infection ORL → céphalées, déficit neurologique, crise d'épilepsie), Processus expansif, <b>HTIC idiopathique</b> (obèse) | <b>Fuite du LCR</b> (spontanée ou post PL ou post-périturale, y penser en post-partum)<br>Diag : IRM → pachyméningite<br>Voir PL |
| <b>TTT</b> : dexaméthasone et céftriaxone                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |

## Céphalées

### 1. AA

- onset
- location
- qualité
- intensité
- durée
- timing (empêche de dormir)
- symptômes neurologiques associés (photophobie, auras, ataxie)
- nausées/vomissements
- claudication de la mâchoire
- trauma récent
- chirurgie dentaire
- sinusite
- facteurs aggravants
- facteurs qui soulagent
- AF
- ancien trauma

### 2. Status

- signes vitaux
- inspection/palpation du crâne
- ORL
- examen neurologique
- fond d'œil

### 3. DD

- migraine
- céphalées cluster
- artérite temporale (Horton)
- sinusite
- migraine de tension
- HSA
- méningite
- névralgie du trijumeau
- pseudotumeur cérébrale